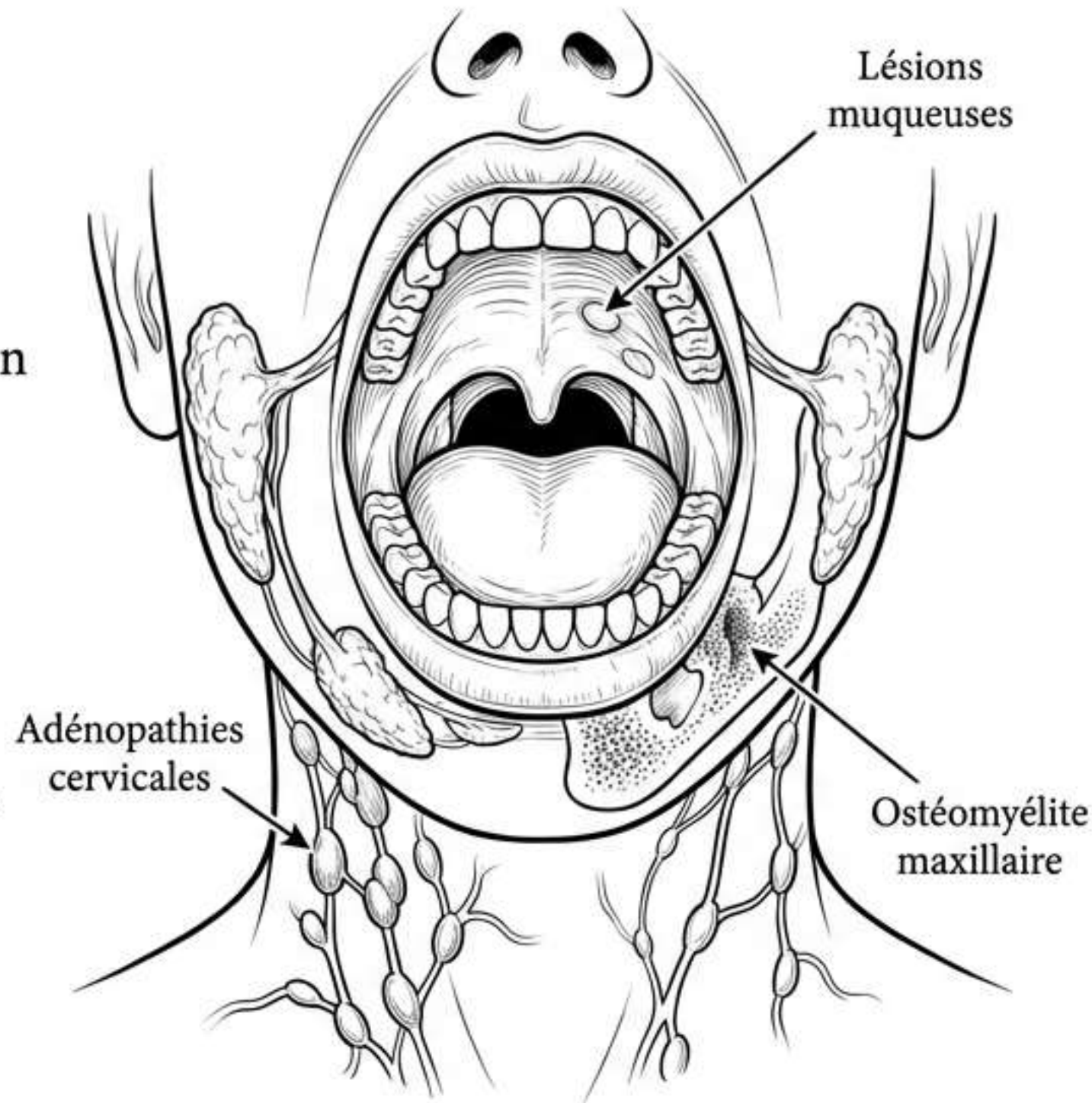


Les Infections Spécifiques de la Muqueuse Buccale – Guide d'Étude Intégral

Tuberculose, Syphilis, Actinomycose (Module : Pathologie et Chirurgie Buccales)

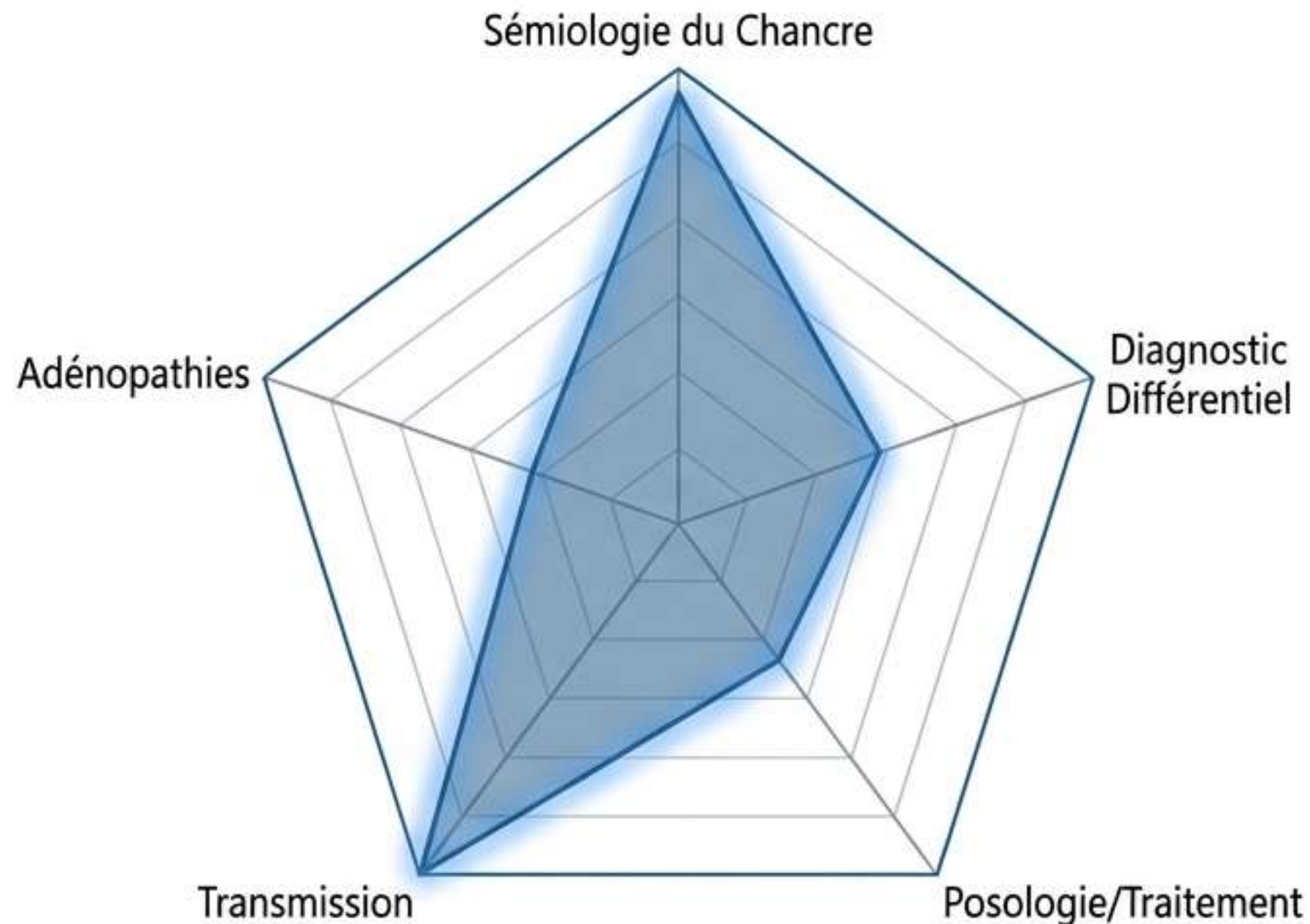
Table des Matières :

1. Analyse des Tendances d'Examen
2. Définitions & Écologie Buccale
3. Tuberculose : Pathogénie et Lésions Buccales
4. Syphilis : La Grande Simulatrice (Stades I à IV)



5. Actinomycose : Bactériologie et Sémiologie
6. Rôle du Stomatologue / Médecin-Dentiste
7. Mind Map de Synthèse Finale

Exam Pattern Analysis : Stratégie de Mémorisation



Thèmes Très Haute Probabilité (Les plus répétés) :

- **Sémiologie comparée du chancre** (Tuberculose vs Syphilis) et contagiosité.
- **Nécrose caséuse** (Tuberculose) **vs Gomme** (Syphilis tertiaire).
- **Manifestations ganglionnaires** (Adénopathies rebelles).

Chiffres Fréquemment Testés :

- **Chronologie Syphilis** : 3 semaines (Primaire), 6 semaines à 3 mois (Secondaire).
- **IDR Tuberculine** : < 5 mm, 5–10 mm, > 10 mm à 48–72h.

Zones de Pièges (Potentiel de nouvelle question) :

- **Posologies** (2.4 millions d'unités Pénicilline G).
- **Phases exactes** du traitement antituberculeux (2 mois + 4 mois).

Alertes du Professeur (Traps) :

- L'Actinomyose **N'EST PAS** un champignon.
- Contre-indication absolue de la Doxycycline chez la femme enceinte.

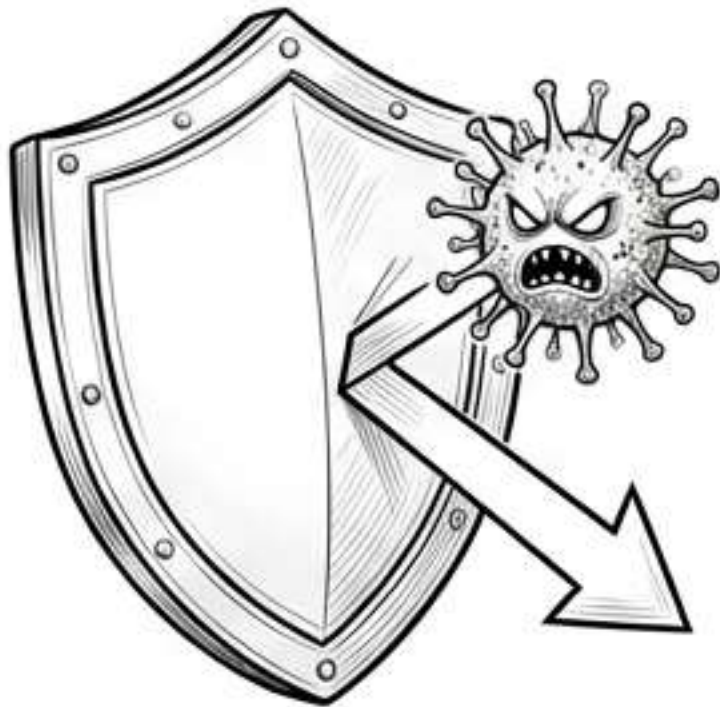
Indice de Confiance de Prédiction : **95%** 
basé sur les annales 2018-2025. 

Concepts Fondamentaux et Écologie Buccale

L'Écosystème Buccal : Tissu exposé en permanence à une flore bactérienne colossale à l'état saprophyte/commensal (non pathogène).

Infection Spécifique :

- Causée par un agent pathogène déterminé et identifiable.
- **Agent exogène / Pathogène strict :** N'appartient pas à la flore buccale commensale.
- **Caractéristiques :** Étiologie précise, clinique typique, traitement ciblé.



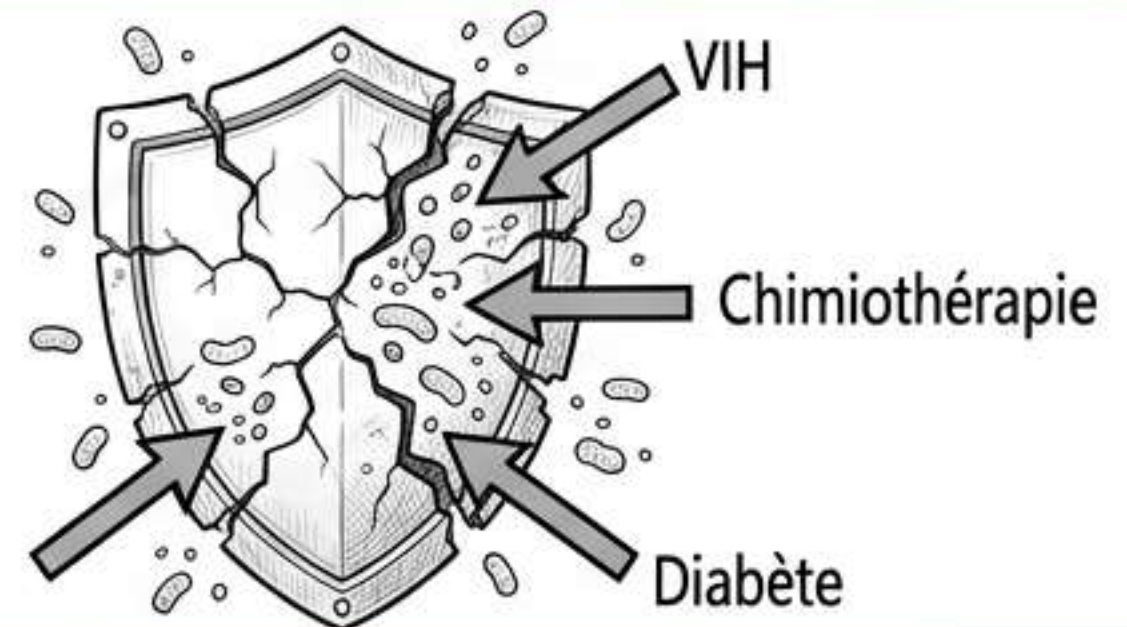
Agent Exogène Strict

Infection Opportuniste :

- Provoquée par une flore endogène (déjà présente, peu virulente).
- Déclenchée par l'altération des défenses immunitaires.

Causes de l'Immunodépression :

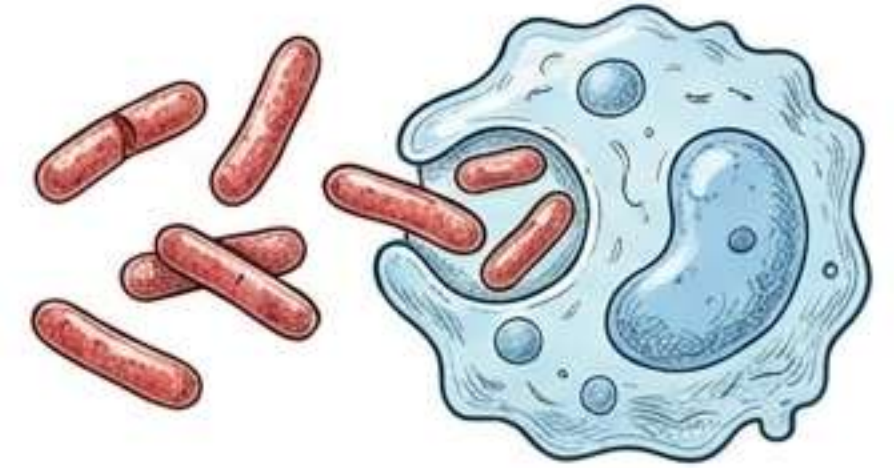
- Infections VIH, Diabète déséquilibré.
- Traitements immunosuppresseurs, Corticothérapie prolongée.
- Neutropénie (diminution des polynucléaires neutres).
- **Chimiothérapie anticancéreuse :** Dès le 7^{ème} jour, apparition d'une cytopénie (diminution des 3 lignées : globules blancs, globules rouges, plaquettes) *[Predicted - Explication orale détaillée du prof, hautement ciblable en QCM].*



Tuberculose : Étiologie et Voies de Contamination

Agent Étiologique : *Mycobacterium tuberculosis* ou Bacille de Koch (BK).

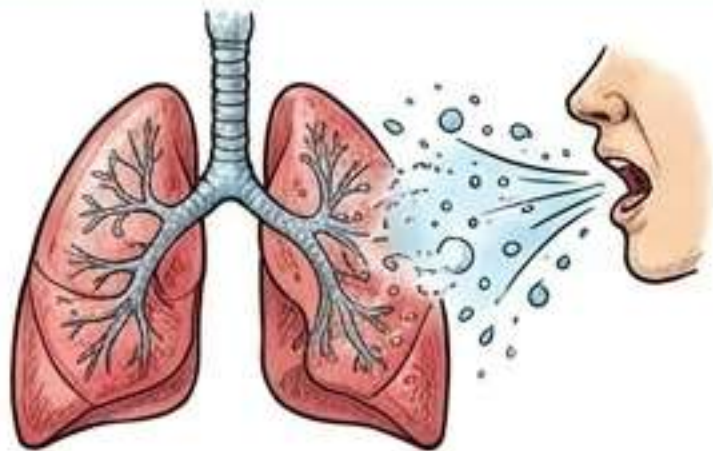
- **Propriétés :** Sensible à la chaleur, lumière solaire, UV. Détruite par l'alcool à 70°.
- **Survie :** Plusieurs jours dans les expectorations (crachats).
- **Pathogénicité :** Ne sécrète PAS de toxines. Survit et se multiplie en intracellulaire (macrophages), formant des granulomes caractéristiques.



Survie intracellulaire (macrophages)

Voies de Transmission (Exclusivement interhumaine) :

1. La voie de transmission la plus fréquente est la **voie aérienne** (Inhalation de gouttelettes de salive d'une tuberculose active lors d'une toux, parole, éternuement) [Ref : Q2].
2. **Voie digestive** : Consommation de lait non pasteurisé / non stérilisé de vache atteinte de mammite tuberculeuse [Predicted – Insistance spécifique du prof sur le danger du lait du marché local].
3. **Voie transcutanée** (piqûre accidentelle, rare).
4. **Voie transplacentaire** (Tuberculose congénitale / trans-génitaire : nouveau-né contaminé *in utero* ou à la naissance).
5. **Contact direct** avec sécrétions infectées (urines, fistules).



Aérienne - la plus fréquente ++



Digestive - lait non pasteurisé



Transcutanée



Transplacentaire

Démarche Diagnostique de la Tuberculose

Radio + Expectations

Étape 1 : Examens de Première Intention



Étape 1 : Examens de Première Intention

- Radiographie thoracique (image révélatrice).
- Examen direct et cultures des expectorations.
- Analyse du liquide de cyto-ponction ganglionnaire, biopsie de lésion suspecte ou biopsie osseuse.

Biopsie / Cyto-ponction

Étape 2 : Confirmation Bactériologique

- Identification du BK dans : expectorations, ganglions, liquides articulaires/osseux.

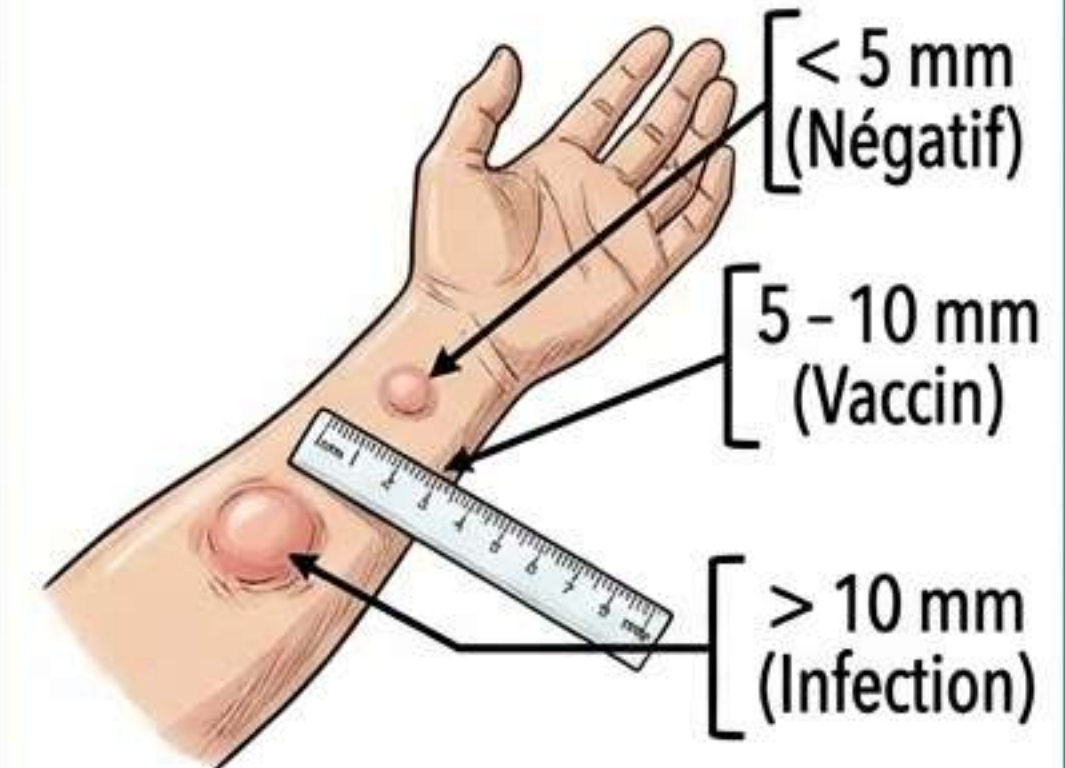


- Identification du BK dans : expectorations, ganglions, liquides articulaires/osseux.

IDR à la tuberculine

Étape 3 : Intradermoréaction (IDR) à la tuberculine

- Dépistage de la primo-infection ou tuberculose latente.



- Dépistage de la primo-infection ou tuberculose latente.
- Méthode : Injection intradermique à l'avant-bras. Lecture stricte à 48-72 heures.

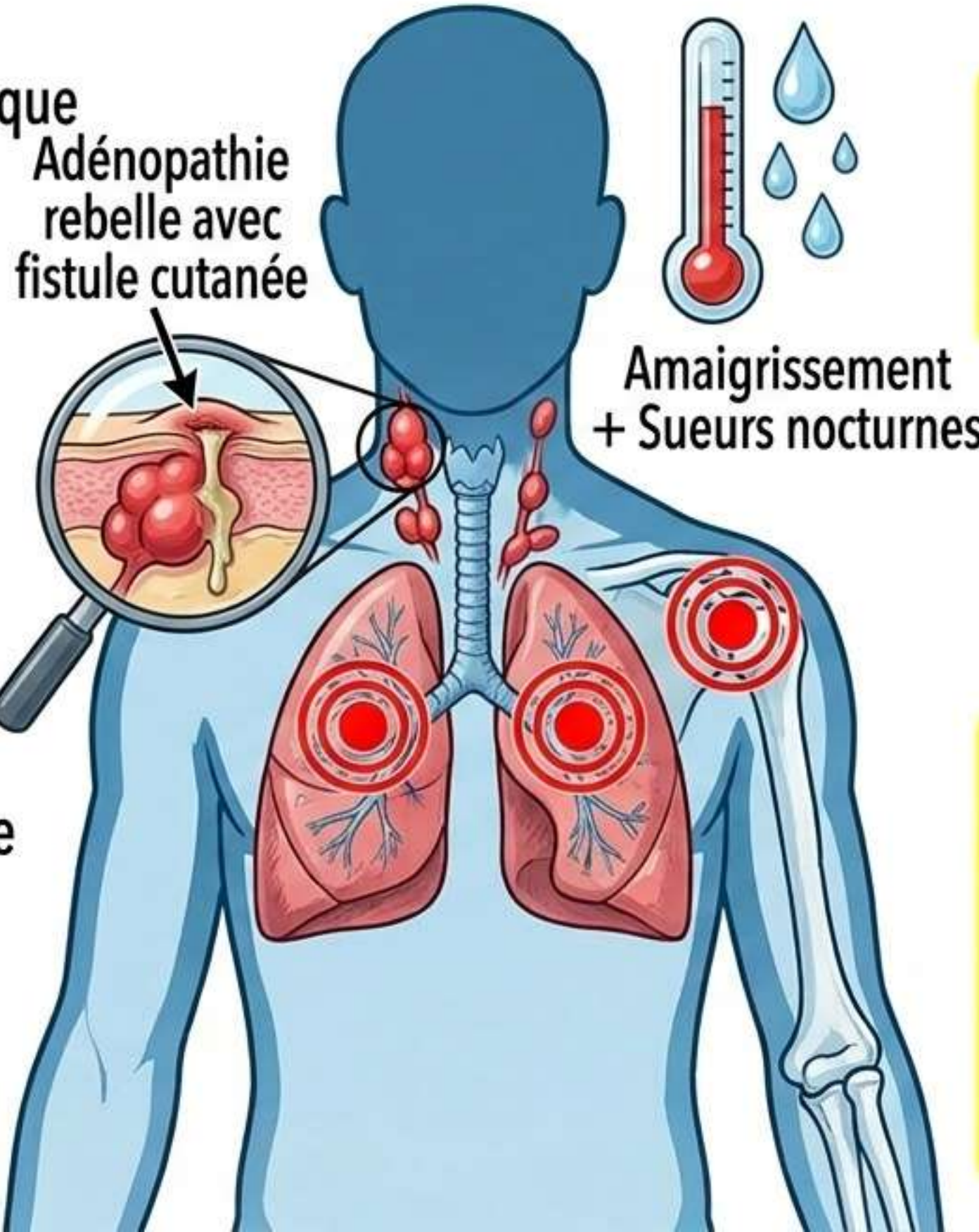
Évolution, Manifestations Générales et Tissulaires

Formes Cliniques :

- Infection latente : Asymptomatique (majorité des cas).
- Tuberculose maladie : $\approx 5\%$ des primo-infectés. Guérison spontanée fréquente, mais risque massif de dissémination (hématogène/lymphatique) en cas de VIH.

Symptomatologie Générale :

- **Signes généraux** : Asthénie, anorexie, amaigrissement, fièvre prolongée, sueurs nocturnes.
- **Signes respiratoires** : Toux persistante, expectorations parfois hémoptoïques (sang).



Signature Tissulaire :

La caséification ou nécrose caséuse est caractéristique du granulome tuberculeux [Ref : Q8].

L'Archétype d'Examen (Cas Clinique Classique) :

Patient de 12 ans + tuméfaction génienne basse + fistule cutanée rebelle aux antibiotiques + amaigrissement + sueurs nocturnes = **Diagnostic direct : Adénopathie tuberculeuse** [Ref : Q1, Q5].

Tuberculose Buccale : Formes et Lésions Cliniques

Généralités

- Lésions buccales rares. Souvent secondaires (auto-inoculation par crachats pulmonaires sur une plaie buccale) ou par extension locale. Localisations : Langue, joue, gencive, palais, lèvres. Polymorphe.

Tuberculose Primaire (Chancre d'inoculation) :

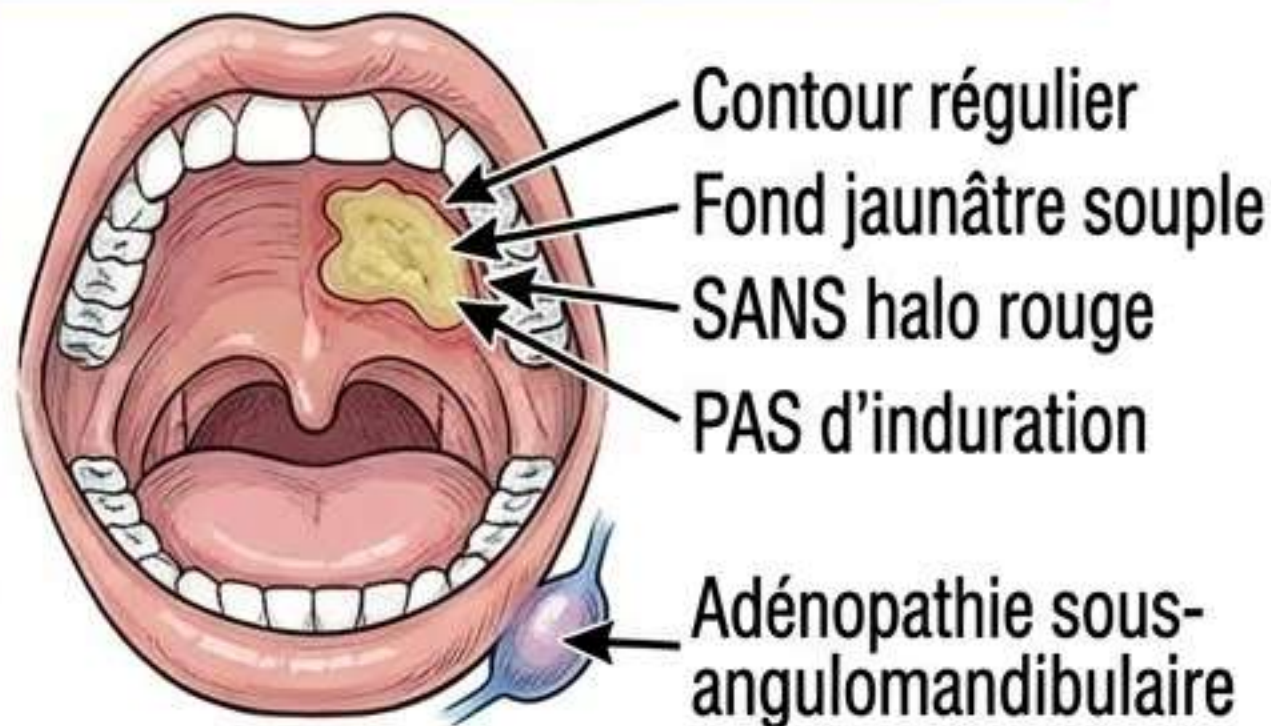
Se présente sous forme d'une ulcération extensive et indolente, de contour régulier, à fond uniforme jaunâtre et SANS halo périphérique rougeâtre. Bords fins, fond fibrino-purulent [Ref : Q10 (Q5 2018)].

Contrairement à la syphilis, il n'y a PAS de base indurée au toucher [Predicted - Différenciation cruciale lourdement insistée à l'oral].

Associée à une adénopathie satellite sous-angulomandibulaire.

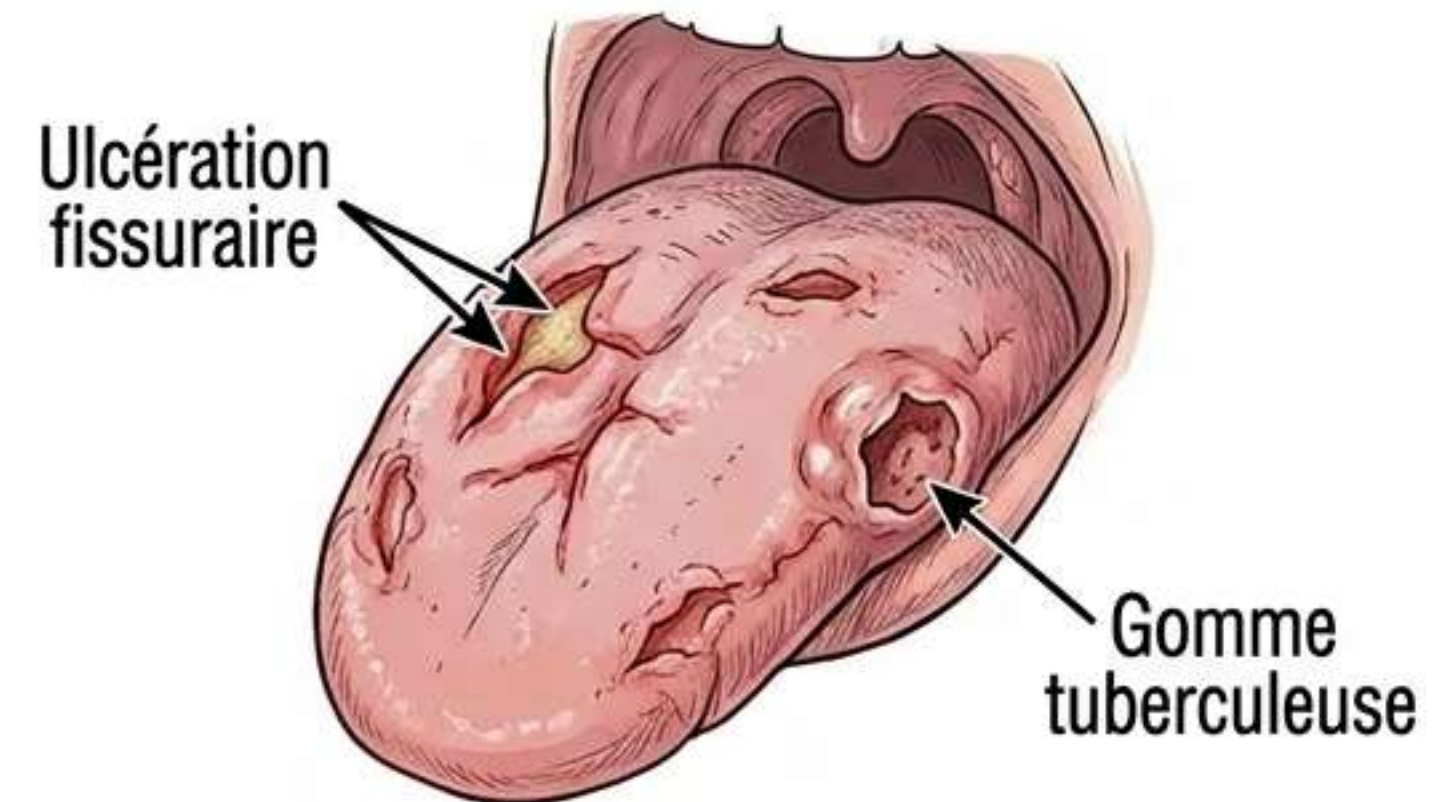
Complications :
Fistulisation,
ostéomyélite.

Complications sous-angulomandibulaire.
Complication,
ostéomyélite.

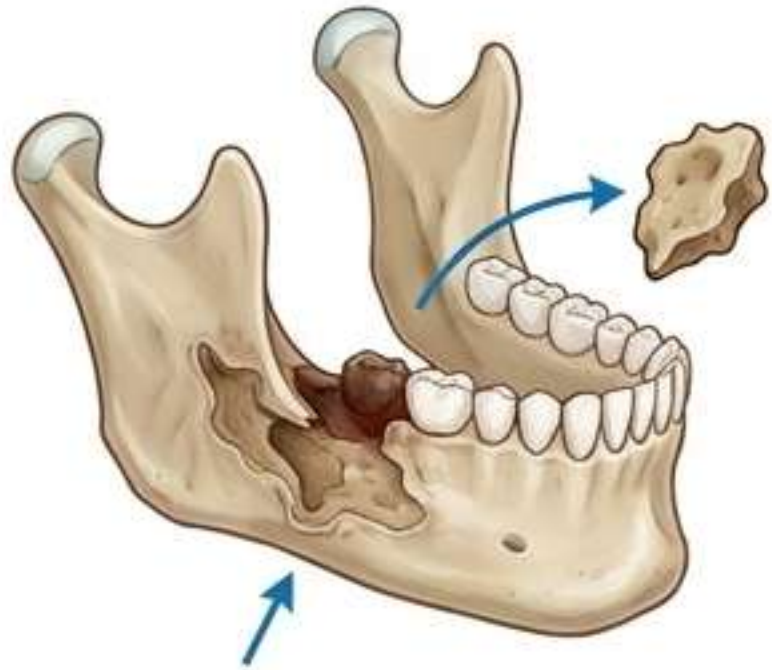


Tuberculose Secondaire :

- Ulcérations linguales : Douloureuses, fissuraires, à fond granulomateux.
- Gommès tuberculeuses : Profondes et fistulisées.
- Lésions verruqueuses : Rares, plaques hyperkératosiques.



Complications Locales, Diagnostic Différentiel et Traitement (TB)



Ostéomyélite -
Séquestres

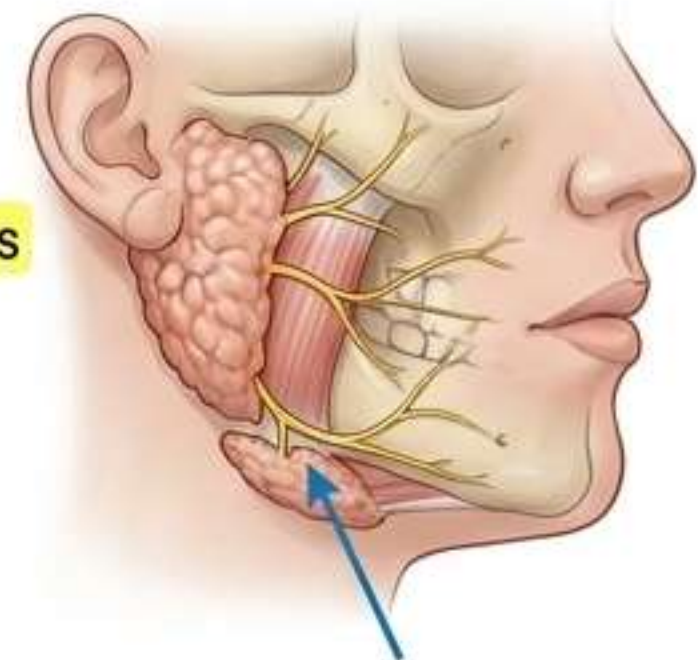
Atteintes Osseuses et Annexes :

- **Ostéomyélite des maxillaires** (Mandibule > Maxillaire) : Dissémination hématogène. Provoque déformation, fistules, séquestres, hyperostose.
- **Glandes salivaires** : Parotide ou sous-mandibulaire. Abscès froid.
Une paralysie faciale est possible car le nerf facial traverse la parotide [Predicted - Corrélation anatomique orale].
- **Lymphadénopathies** (Écrouelles) : Ganglions indolores, multiples, fistulisés.

Diagnostic Différentiel de l'ulcération buccale :

Se fait avec le chancre de syphilis primaire, l'actinomycose, les gommes syphilitiques, kystes dermoïdes, fibromes et lipomes [Ref : Q4].

Autres : Carcinome épidermoïde (induration dépassant la lésion), Lésions traumatiques, Lichen plan érosif, Herpès, VIH, Mycoses, Behçet, Sarcoidose.



Parotide - Risque
Paralysie Faciale

Protocole de Traitement (6 mois total, per os) :

Phase intensive (2 mois) :		Phase de continuation (4 mois) :			
 R + I + P + E		 R + I			
Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6

Prévention :

- Vaccin BCG, dépistage/isollement, pasteurisation du lait.

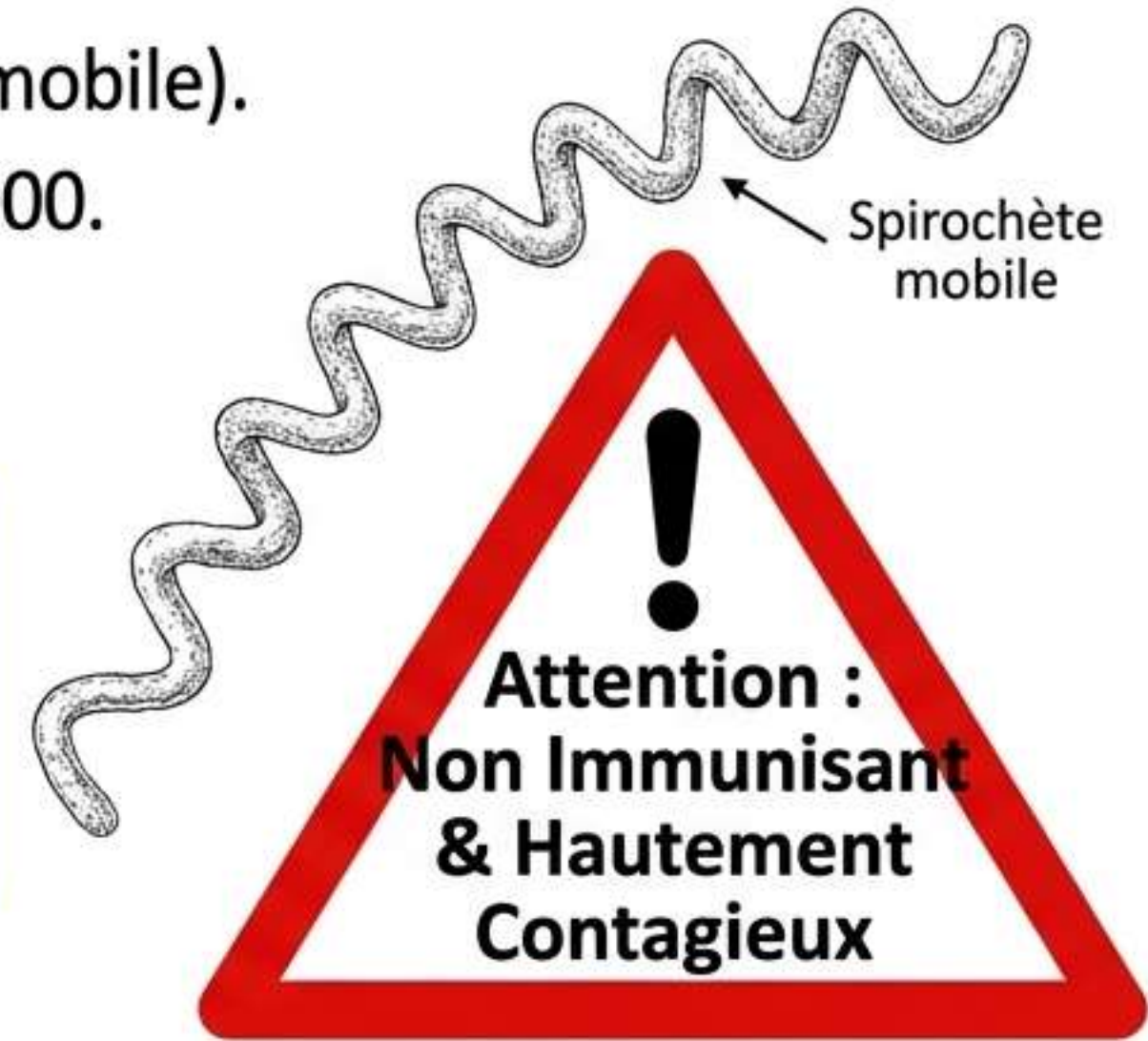
Syphilis : La Grande Simulatrice (Généralités)

- **Agent Étiologique** : *Treponema pallidum* (bactérie, spirochète mobile).
- **Profil Épidémiologique** : Incidence en recrudescence depuis 2000.
Forte association avec le VIH (notamment HSH).

Caractéristiques Fondamentales de l'Infection : C'est une **Infection Sexuellement Transmissible (IST)**, non immunisante (réinfection possible), dont les lésions muqueuses sont très contagieuses [Ref : Q3]. La contagiosité est maximale aux stades primaire et secondaire.

Modes de Transmission :

- **Sexuelle (≈ 95 %)** : Par contact direct avec une lésion infectieuse.
- **Transplacentaire** : Provoquant la syphilis congénitale (possible dès le 2ème trimestre).
- **Exposition sanguine** : Exceptionnelle aujourd'hui (dépistage systématique des transfusions).



Sexuelle 95%



Transplacentaire

Évolution Clinique : Stades I et II (Hautement Contagieux)

TRÈS CONTAGIEUX

Semaine 3

1. Syphilis Primaire (Apparaît ≈ 3 semaines après contamination) :

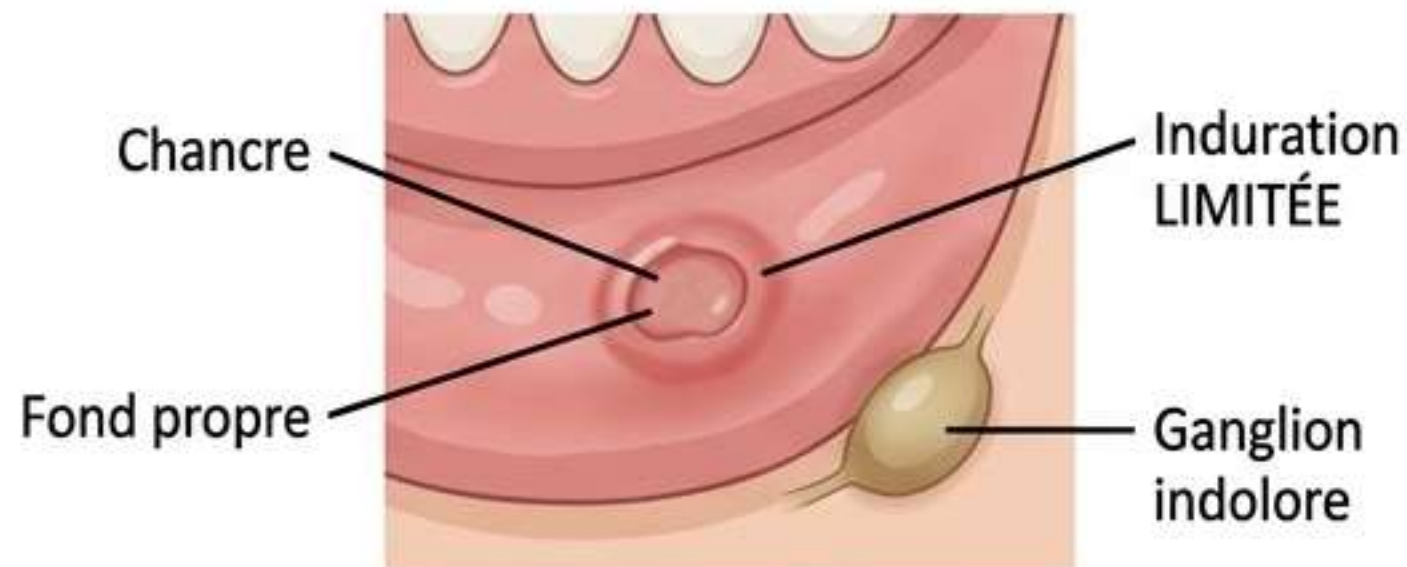
Le Chancre Syphilitique : Le chancre est très contagieux [Ref : Q2 2023].

- **Sémiologie** : Ulcération unique, indolore, bien limitée, fond propre et lisse (≈ 1 cm).

Induration ferme strictement limitée à la lésion (sensation de carton), contrairement au carcinome où l'induration dépasse la lésion [Predicted - Piège diagnostique majeur oral].

- Cicatrisation spontanée (3 à 6 semaines).

Adénopathie satellite (sous-mandibulaire) : dure, mobile, indolore, sans signes inflammatoires.



Semaines 6 à 3 Mois

2. Syphilis Secondaire (Survient 6 semaines à 3 mois après chancre) :

- Dissémination hémotogène polymorphe.
Signes : Fièvre, asthénie, arthralgies, polyadénopathies.

Peau : Roséole cutanée, syphilides, éruption maculo-papuleuse [Ref : Q7 2018].

- Atteinte palmo-plantaire, alopecie en clairière.

Muqueuses (Très contagieuses) : Plaques muqueuses érosives [Ref : Q7 2018], condylomes plans (Contrairement aux condylomes HPV qui sont saillants/verruqueux [Predicted]), rhagades labiales, langue fauchée (lisse/rouge).

Les manifestations buccales se voient à TOUS les stades de l'évolution (I, II, III) [Ref : Q6].



Roséole



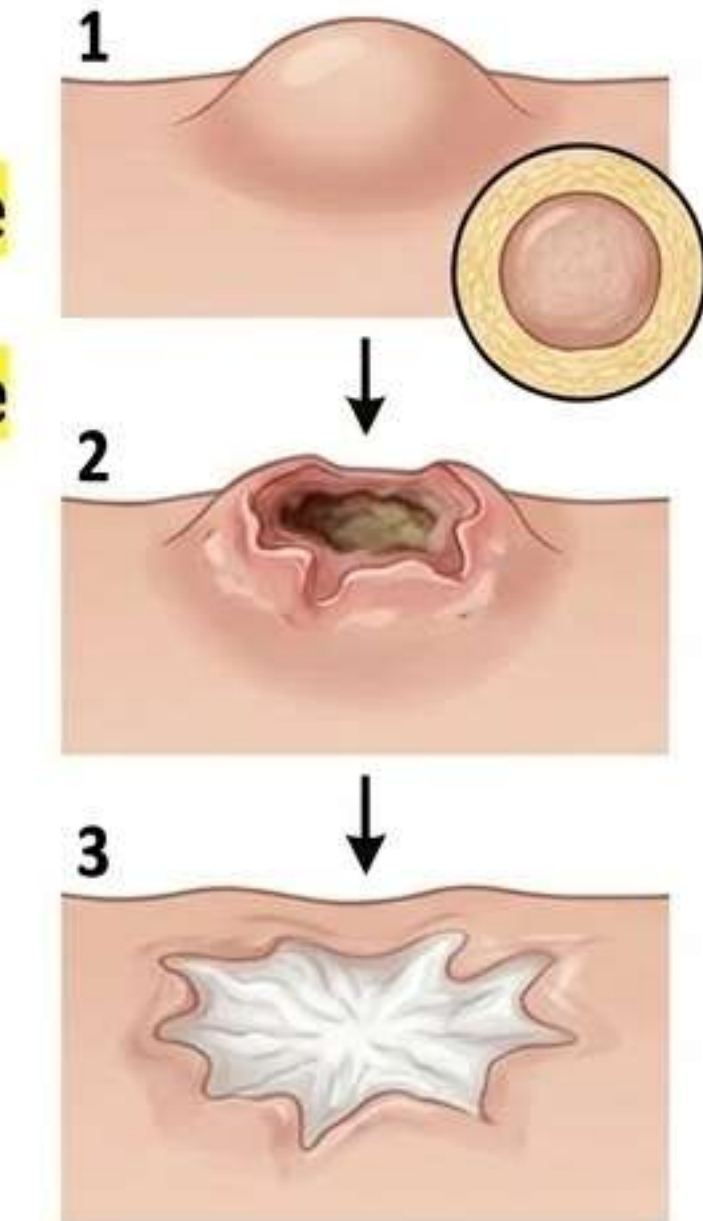
Langue fauchée

Évolution Tardive : Syphilis Tertiaire et Congénitale

3. Syphilis Tertiaire (Phase tardive et peu contagieuse) :

- Survient après une phase de latence prolongée (jusqu'à 15 ans).

- **La Lésion Caractéristique :**
Une **gomme** est l'expression de la syphilis tertiaire. C'est un nodule hypodermique **indolore et mobile**, évoluant vers le ramollissement, s'ulcérant (nécrose sans caséification) et se vidant en laissant des cicatrices [Ref : Q18, Q6 2018].



La Gomme (Tertiaire) :
Nodule ->
Ramollissement -> Cicatrice

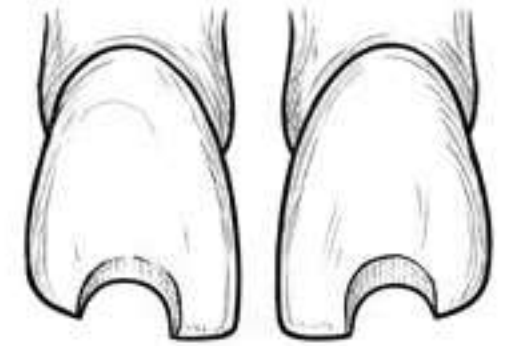
- **Atteintes systémiques :**
Cardiovasculaires,
Neurosyphilis.
Localisations
faciales/buccales rares mais
destructrices.

4. Syphilis Congénitale :

- Transmission mère-enfant par **voie transplacentaire** (dès le 2^{ème} trimestre).

- **Forme précoce :** Atteintes viscérales sévères.
- **Forme tardive** (Anomalies ostéo-dentaires pathognomoniques) :

- **Dents d'Hutchinson :** Incisives centrales supérieures avec malformations (échancrées / en tournevis).
- **Molaires de Moon (ou de Fournier) :** Molaires en forme de mûre ou de fleur (multiples cuspides).
- **Palais ogival.**



Dents d'Hutchinson
- tournevis



Molaires de Moon - mûre

Examens Sérologiques et Protocole Thérapeutique (Syphilis)

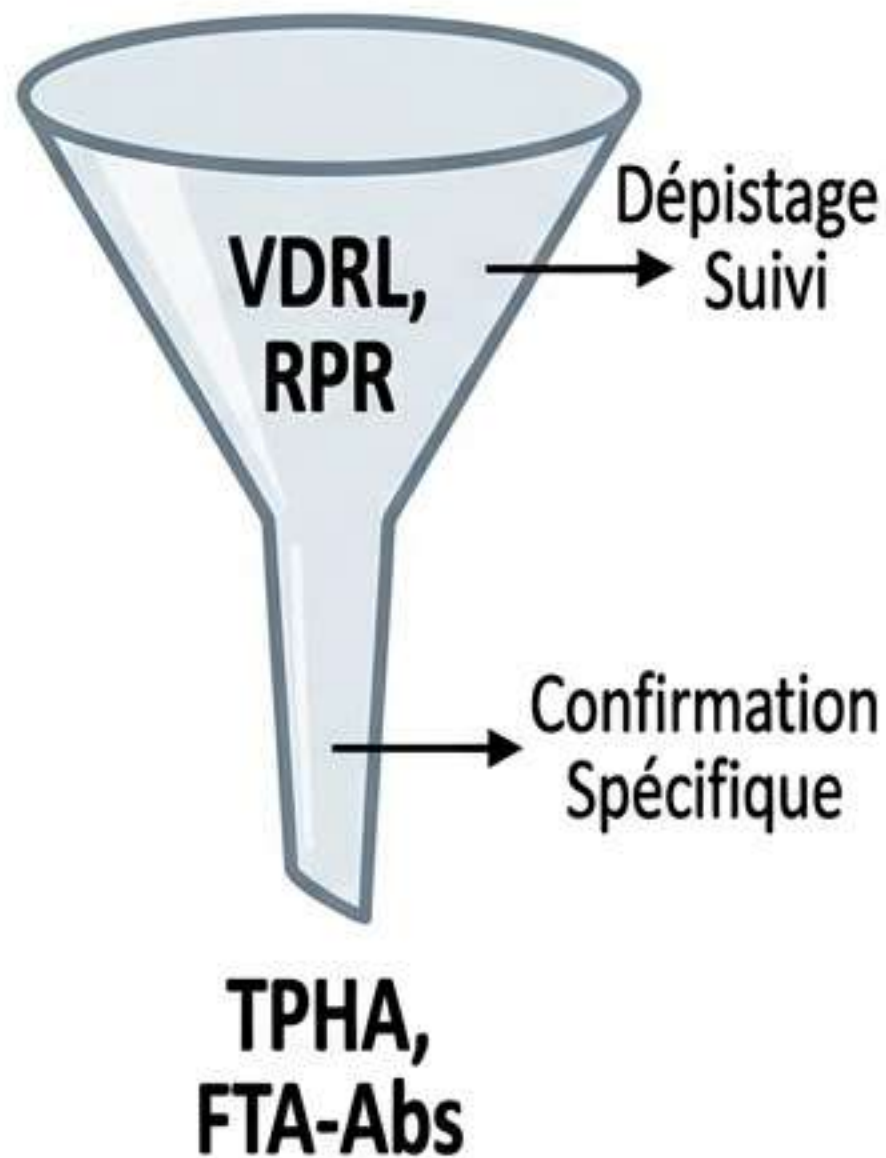
Diagnostic Sérologique

(Méthode de référence) :

- **Histologie** : Infiltrat riche en plasmocytes. Microscope à fond noir (rare).
- **Tests non tréponémiques** (VDRL, RPR) : Dépistage et suivi de l'activité.

Peuvent être faux négatifs en phase de latence si la charge bactérienne est très faible [Predicted - Explication orale].

- **Tests tréponémiques** (TPHA, TPPA, FTA-Abs) : Confirmation (spécifiques à la bactérie).



Traitement de Référence : Pénicilline G benzathine (Extencilline®)

- **Primaire, Secondaire, Latente précoce** : 2,4 millions d'unités en Intra-Musculaire (IM), dose unique.
- **Latente tardive** (>1 an) / **Inconnue** : 2,4 millions d'unités IM, 1 injection/semaine pendant 3 semaines.
- **Neurosyphilis** : Pénicilline G IV pendant 10 à 14 jours.



Extencilline® :
2.4 Millions Unités IM

Alternative et Contre-indications (Allergie) :

- **Alternative standard** : Doxycycline.

La Doxycycline est formellement **CONTRE-INDIQUÉE** chez la femme enceinte et l'enfant < 8 ans (risque d'hypoplasie de l'émail et coloration dentaire).

Solution : Désensibilisation à la pénicilline [Predicted - Grande insistance orale].



Doxycycline
CONTRE-INDIQUÉE
(Grossesse/Enfant)
-> Hypoplasie émail

Actinomyose : Bactériologie et Physiopathologie

Généralités :

- Infection bactérienne chronique suppurée, rare, peu contagieuse. Évolution lente, fistulisante et fibreuse.

Microbiologie et Étiopathogénie :

- Agent : *Actinomyces israelii*. Bactérie anaérobie, Gram positif, filamenteuse.

Piège absolu : Contrairement à l'étymologie grecque, ce n'est **PAS** un champignon. C'est une **bactérie commensale** (flore buccale/digestive) [Predicted].

- **Facteurs favorisants** (Rupture barrière muqueuse) : Extraction dentaire, traumatisme, mauvaise hygiène, diabète, immunodépression.

Alcool-tabagisme : L'alcool augmente drastiquement la perméabilité de la muqueuse [Predicted].

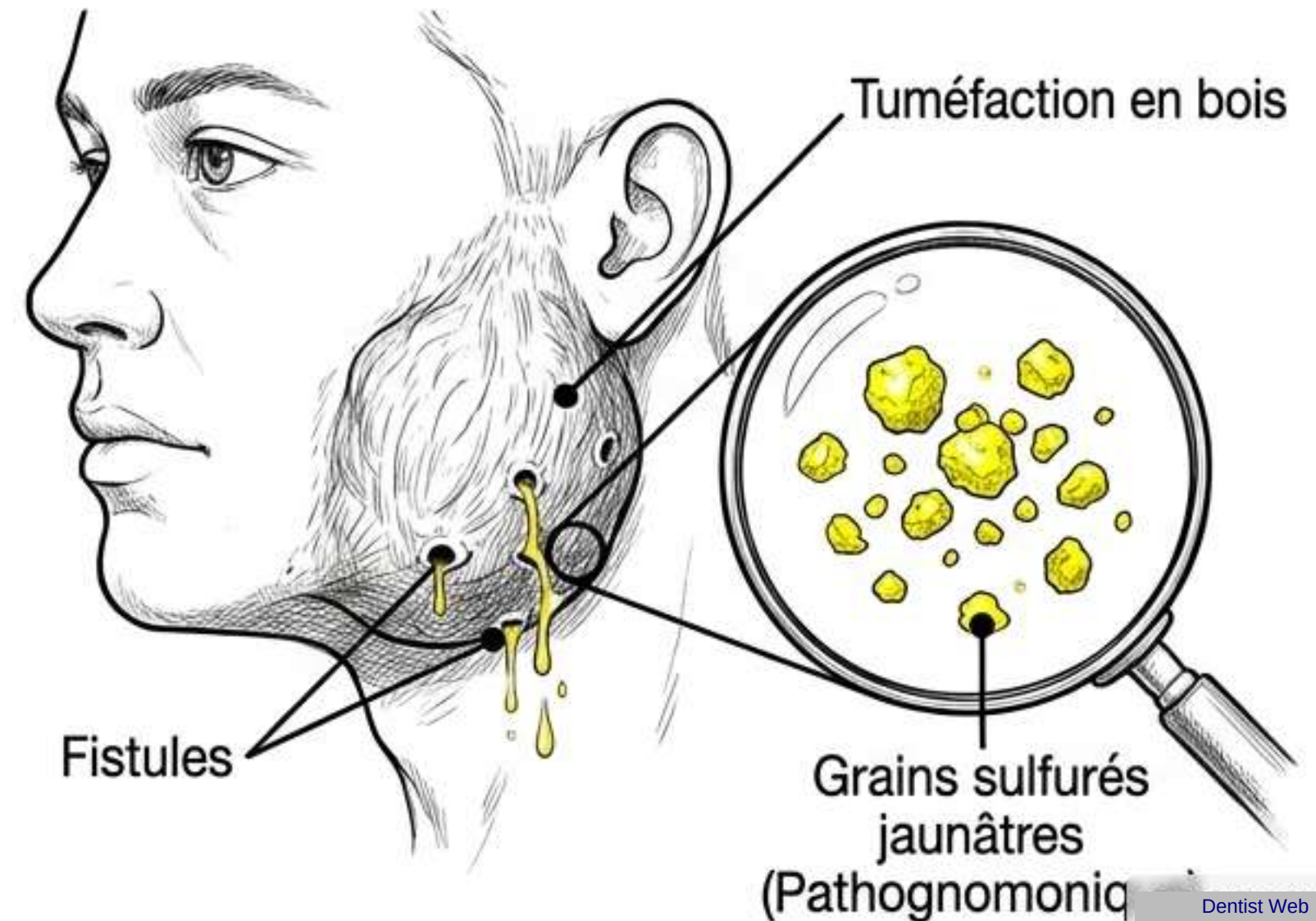
- **Extension :** Uniquement par contiguïté (pas de dissémination hématogène). Crée un environnement anaérobie avasculaire (limite l'action des antibiotiques).



PAS un champignon !
Bactérie Gram+
Anaérobie

Étude Clinique (Forme cervico-faciale : 50-60%) :

- Tuméfaction indurée (en bois) de l'angle mandibulaire/parotide. Douleur modérée, trismus.
- Abscesses multiples et fistulisation cutanéomuqueuse.
- **Signe Pathognomonique :** Écoulement de pus séro-sanglant contenant des grains sulfurés (granules jaunâtres).



Prise en charge de l'Actinomyose & Rôle du Praticien

Diagnostic de l'Actinomyose :

- **Macroscopique** : Présence de grains jaunâtres.
- **Microscopique** : Filaments avec extrémités en massue. Culture anaérobie prolongée.
- **Diagnostic différentiel** : Tumeurs malignes, tuberculose, mycoses profondes, lésions radio-induites.

Traitement de l'Actinomyose :

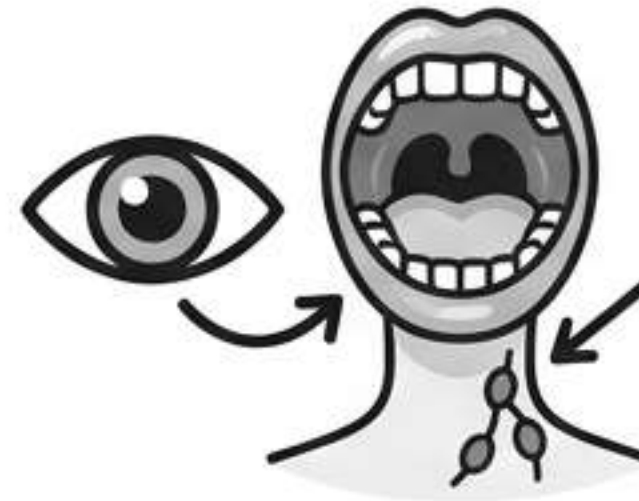
- **Antibiothérapie prolongée à forte dose** : Pénicilline G IV puis relai Amoxicilline per os.
- **Durée totale très longue** : 6 à 12 mois (adaptation clinique). En cas d'allergie : Doxycycline, Clindamycine, Macrolides.
- **Chirurgie** : Drainage, curetage, exérèse des tissus fibreux.



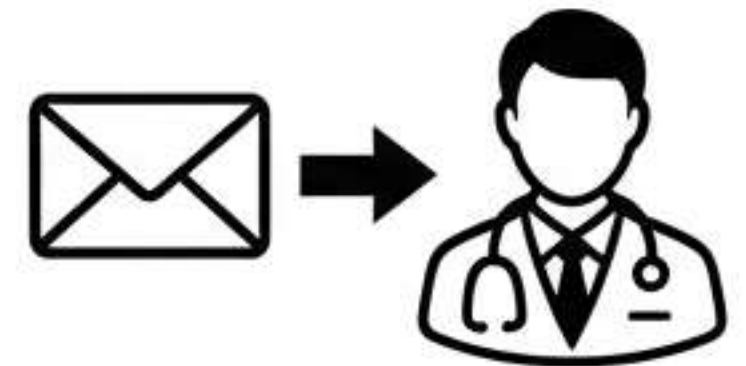
Traitement long : 6 à 12 Mois
(Pénicilline / Amoxicilline) + Drainage chirurgical

Le Rôle du Stomatologue / Médecin-Dentiste :

- **Prévention & Asepsie** : Stérilisation, désinfection du cabinet, éducation à l'hygiène.
- **Dépistage Systématique** : Examen clinique rigoureux de 30 secondes de toute la muqueuse et palpation des aires ganglionnaires lors de tout soin classique.
- **Orientation et Collaboration** : Rédiger une lettre d'orientation formelle vers le médecin traitant (ex: diabétologue, infectiologue) pour confirmer le statut immunologique/thérapeutique. Ne jamais se contenter des seules déclarations du patient.



Examen Muqueuse/Ganglions
30 sec



Lettre d'orientation
formelle

Synthèse Diagnostique Intégrale : Infections Spécifiques Buccales

Le Concept Central : Lésions chroniques spécifiques de la cavité buccale.

